

RFC-003 - Solicitud de Cambio (RFC)

Sistema de Gestión para un Centro Médico — PFC UTEQ, ISR-401

Base: PE2 (elicitación y análisis) / Anexo C — PE4 Unidad IV.

ID	RFC-001
Fecha	21/07/2026
Solicitante y rol	Analista de Requisitos del equipo (rol: Analista) - a partir de un conflicto detectado en la inspección del documento del PE2
Requisito afectado	RNF-06 / RNF-08 (corrección de trazabilidad; ligado a LOPDP)
Tipo de RFC	Restricción / normativa
Descripción del cambio	Formalizar y corregir la inconsistencia de identificadores detectada en la inspección del ERS: el Acta de Negociación N.º1 (sección 4.3.4) cita "RNF-06: acceso restringido solo al médico tratante" como el requisito resultante del conflicto de metas, pero en la tabla de clasificación RNF (sección 4.3.1) RNF-6 corresponde a "recuperación ante fallos <=5 minutos", un atributo de calidad distinto. El requisito de control de acceso queda correctamente definido más adelante, en la sección 4.5.4, como RNF-08. Se solicita renombrar toda referencia a "RNF-06" (control de acceso) por RNF-08 en el Acta de Negociación N.º1 y en la matriz de trazabilidad, dejando RNF-6 exclusivamente como el NFR de recuperación ante fallos.
Justificación de negocio	La colisión de IDs genera riesgo de que el equipo de desarrollo implemente el requisito equivocado (recuperación ante fallos en vez de control de acceso, o viceversa), lo que comprometería el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador, dado que RNF-08 es precisamente el control que impide el acceso no autorizado al historial clínico.
Requisitos impactados (desde la matriz de trazabilidad)	RNF-06 (recuperación ante fallos, sin cambio de contenido, solo se protege su ID), RNF-08 (formalizado como único ID válido para control de acceso), RF-09-R (control de acceso RBAC, Acta de Negociación N.º1), RF-10 (registro de auditoría).
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	Acta de Negociación N.º1 (sección 4.3.4), matriz de trazabilidad, ERS secciones 4.3.1 y 4.5.4, CU "Gestionar Historial Clínico del Paciente" (Fig. 6), Misuse Scenario MS-1.
Alternativas consideradas	(a) Dejar ambas referencias como están y aclarar solo en un comentario interno (rechazada, no elimina el riesgo de trazabilidad); (b) Renumerar RNF-6 (recuperación ante fallos) en vez de la referencia de control de acceso (rechazada, RNF-6 ya está correctamente enlazado en la matriz); (c) Unificar toda referencia de control de acceso bajo RNF-08, dejando RNF-6 intacto (opción elegida, por ser la de menor esfuerzo y menor riesgo de romper trazabilidad existente).
Costo estimado (horas-persona) /Riesgo	8 horas-persona (corrección documental y actualización de matriz de trazabilidad; no requiere cambio de código). Riesgo: Bajo en lo técnico, pero alto en lo legal/de cumplimiento si no se corrige antes de iniciar el desarrollo del control de acceso.
Recomendación Técnica	Aprobar sin condiciones. Corrección documental de prioridad alta, a aplicar de inmediato en la versión 1.1 del ERS.
Decisión del CCB	Aprobado
Justificación de la decisión	Es una corrección de trazabilidad sin impacto en código; su no corrección representa un riesgo de cumplimiento de la LOPDP.
Responsable(s)	Díaz Pontón, S. (analista responsable de la matriz de trazabilidad)

Plazo	Aplicado de inmediato en la v1.1
--------------	----------------------------------